共建的两个账本-跨域能力共建工程的“双相效应”伪实证比较研究

无力吐槽[1]、丧失斗志[1*]、神奇领导[2]

1. 呵呵哒技校萌萌哒学院，A 市，11111X

2. 好单位，B 市，22222Y

摘　要：跨域能力共建工程通常以“技术输出、体系共建、能力复制”的语言呈现，但实践中常出现一种不太体面、却极其稳定的结构：临床与服务端的可见增益可以与学科与生态端的隐性失血同时发生。本文用公开资料比较法选取 5 个典型案例，分别呈现两种机制路径：其一为“技术帮扶型”，以培训—标准—在地闭环为核心，使能力沉淀在承接方；其二为“资源虹吸/依赖锁定型”，以权力重排、现金流控制或病源/资金/话语权集中为核心，工程虽打着“共建”的旗号，却在运行中削弱本地生态与长期自我造血能力。本文强调相对观点：即便在被批评为“虹吸”的项目中，也可能确实带来新技术开展与短期服务改善；争议的关键不在“有没有帮扶”，而在“帮扶是否以抽底式重排本地战略资源为代价”。

关键词：跨域协同；能力共建；技术外溢；资源虹吸；组织生态

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言

跨域共建这件事，最容易被误读成一条单行道：要么是高尚的技术外溢，要么是赤裸的资源掠夺。现实更像双账本会计。台面账本写的是“新技术开展、路径更新、门诊量上升、疑难危重救治能力提升”；台下账本写的是“病源与资金流向、骨干与平台归属、数据与话语权控制、基层生态被抽空”。更要命的是，两本账不互相否定，甚至互相成全：台面越亮，台下越不容易被问责。

因此本文不把问题写成道德审判，而把它写成机制比较：当一个工程自称“共建”时，它究竟是在复制对方的能力，还是在复制对方对自己的依赖？

2. 实验方法

本文采用公开材料的比较案例研究。纳入的案例需满足三个条件：第一，带有明确的“跨域能力共建/重建/协作”叙事；第二，存在可核验的公开数据或权威报道；第三，能观察到能力是否“沉淀在地”或价值是否“结构性回流”的机制线索。

分析时，我们把结果拆成两个维度，但写作上不做“条条框框”的断裂式陈列：

一是可见产出（临床技术、服务可及性、流程规范化等）；

二是生态产出（梯队、平台与数据资产、资金与病源流向、治理权与评价权的归属）。

所谓“资源掠夺/不尊重本地生态”，在本文中并不等同于某个个体动机，而指向一种结构结果：本地长期能力建设的关键要素被系统性外部化或被压扁到无法自我迭代。

3. 实验结果

5 个跨域能力共建工程的实施效果对照

案例 1（资源虹吸/依赖锁定型）：委内瑞拉“政治斩首（拘捕）+能源出口再托管”的共建。

如果把“斩首”理解为政治学意义上的“移除最高决策节点”，那么委内瑞拉在 2026 年初的事件提供了一个极端清晰的模板：美方通过军事行动拘捕委内瑞拉时任总统马杜罗，并将其带往美国面对刑事指控，事件本身即被路透社以“captured”描述。 随后，围绕能源部门的“重建/恢复投资”叙事迅速出现，但控制点并不在口号，而在结算与出口治理。路透社报道称，在这一政治变动后，华盛顿“接管”并通过授权框架重塑委内瑞拉原油出口管理，若干贸易商与公司在美方授权下管理大部分出口。

这一案例之所以适合放在“跨域能力共建工程”的结果里，是因为它常以“帮助恢复能源产业、带来投资与技术”的语言包装，但其生态后果非常典型：本地资源部门的关键权能从“在地主权型控制”转向“外部授权型控制”，形成一种高强度依赖锁定。临床类比到医疗共建，就是“你能开展新术式，但你的核心现金流、关键平台与评价权不再主要由你掌握”。

案例 2（资源虹吸/生态不适配型）：阿富汗重建——“国家能力建设”叙事下的巨大浪费与不可持续

阿富汗重建长期以“国家能力建设、制度重建”的名义运行，是典型的跨域能力共建工程。但大量监督材料与报道不断指向同一类后果：项目规模巨大，却出现系统性失败、浪费与不可持续。Defense One 报道援引监督机构最终报告的结论，指出美国政府在阿富汗重建上投入超过 1480 亿美元，并将其刻画为失败的重建努力。Lawfare 对监督报告的解读同样强调“严重系统性问题”并将重建任务描述为失败。

这一案例的关键不只是“花了很多钱”，而是典型的“生态不适配”：工程目标、承包体系、短期绩效与本地治理能力之间长期错配，导致成果难以沉淀在地，反而在合同链条与外部体系中完成价值闭环。把它抽象成共建机制语言，就是工程看似在“建能力”，实际更像在“建一个永远需要你来修的系统”。简而言之，阿富汗必须混乱。

案例 3（资源虹吸/生态扰动型）：医联体/集团化扩张的“跑马圈地—虹吸风险”

国内的跨域共建工程往往更温和，但结构问题并不因此消失。值得注意的是，“共建不等于跑马圈地、不等于把病人虹吸到大医院”这一句，已经在官方语境中反复出现。全国政协关于推进医联体的报道明确指出，推进医联体建设的目的不是“跑马圈地”，不是把病人都虹吸到大医院，而在于疏导优质资源上下贯通、形成有序分级诊疗。 当一个政策需要反复强调“不是这样”，通常意味着“现实里有人容易这样”。

更直白的警惕来自更早的公开表述。人民网对国家卫计委负责人的访谈中就谈到要控制大医院规模、解决大医院“虹吸现象”。 近年的媒体讨论也把“头部医院扩张、医疗资源集中带来的虹吸效应”作为分级诊疗难点之一。 学术文献中，“siphon effect（虹吸效应）”亦被用来描述患者绕过本地机构、流向城市三级中心的结构性现象。

当“共建”被理解成“品牌扩张”或“规模竞争”，本地医疗生态会出现被动失衡——病源与医保资金上移，基层机构功能被压扁，人才与学科梯队难以在地稳定，最终形成“越共建越依赖”的反常结果。这种结构性虹吸，本质上就是对本地生态的低尊重：把当地当作供给端（病源、资金、数据、人才），却不给足其自我造血的制度空间。

案例 4（技术帮扶/能力复制型）：Project ECHO——把“专家稀缺”变成“方法可复制”

Project ECHO 的说服力在于它不靠把患者吸到中心来“做大数据”，而靠把治疗能力复制到基层。NEJM 2011 年的对照研究显示，基层 ECHO 站点治疗丙肝的持续病毒学应答（SVR）为 58.2%（152/261），与大学专科门诊 57.5%（84/146）无显著差异。

这种项目在生态层面的“好”，不是因为它没有利益，而是因为它把收益函数绑定在“基层能独立跑”的结果上：能力沉淀在本地团队，中心的存在感反而应该逐步降低。

案例 5（国内技术帮扶/能力复制型）：医疗人才“组团式”支援与对口帮扶——以人带技、以技带队

国内最接近“技术外溢型共建”的证据，往往来自可核验的组织化培训与梯队建设数据。新华社引述国家卫健委发布会信息称，医疗人才“组团式”援藏援疆已向西藏、新疆选派高水平医疗人才 2500 余名，并接收 4000 余名受援地医务人员到支援医院培训进修，受援地医务人员整体素质显著提升。

在县域能力提升方面，国家卫健委发布会信息经央视报道指出，组织 1173 家三级医院对口帮扶 940 个县的 1496 家县级医院，并披露帮扶县医院服务能力提升的比例变化。

这类项目的共建特征在于，它至少在制度设计上更强调“带队伍、带制度、带闭环”，而不是单次“做项目”。当然它也会面临绩效化、形式化的风险，但从公开数据与政策表述看，其收益函数更接近能力复制，而非资源上收。的公开数据或权威报道；第三，能观察到能力是否“沉淀在地”或价值是否“结构性回流”的机制线索。

4. 讨论

如何识别“打着共建的资源掠夺”，以及为什么它总能在台面上显得很成功。从以上案例可以看出，“资源掠夺/不尊重本地生态”并不一定表现为粗暴夺取，它更常见的形态是结构性外部化：把本地的关键要素（病源与现金流、平台与数据、骨干与话语权）通过授权、托管、评价体系或规模竞争机制，悄悄转移到外部体系中。项目仍然能做出漂亮的台面成绩，因为临床增益确实可以发生，甚至发生得很快；但生态端的损伤往往是慢变量，等它显影时，梯队已断、平台已空、治理权已变现为外部依赖。

更有甚者，在具体执行过程中，这类项目被个别输出方的派驻人员误当成“尚方宝剑”，把制度授权视为个人支配，把协作关系理解为占领关系，进而在被协作机构内部制造新的不稳定——一种不流血的“生态扰动”，演变出“不听话的主任就换掉”、“需要集体决议的事情就一言堂”、“打着项目落地的旗号就个人优先”等啼笑皆非的名场面。

因此，识别“真假共建”最可靠的办法，从来不是看宣传口径，而是看三件事：能力是否在地可复制、关键资产是否在地可控、退出后系统是否还能自我迭代。换句话说，真正的共建应该让输出方越来越不重要；而伪共建会让输出方越来越不可替代，并且把这种不可替代写成“成绩”。

致谢

感谢所有“听过类似故事的人”，以及所有“仍然相信共建比掠夺更高级的人”。感谢 AI 码字。

参考文献（References）

无参考文献。如需核实信息，自行谷歌/百度。